

5 特発性間質性肺炎 idiopathic interstitial pneumonias (IIPs)

A 慢性線維化性間質性肺炎 chronic fibrosing interstitial pneumonia

1 特発性肺線維症 idiopathic pulmonary fibrosis

到達目標

- ・特発性肺線維症の診断に必要な所見を説明できる
- ・特発性肺線維症の急性増悪の診断ができる
- ・特発性肺線維症の治療方針を説明できる

病因・病態・疫学

a 病因・病態

間質性肺炎は、種々の吸入や薬剤性など原因があるものや、膠原病・サルコイドーシスなどの全身性疾患に付随して発症する二次性の間質性肺炎と、病変が肺に限定し原因を特定できない特発性間質性肺炎（idiopathic interstitial pneumonias：IIPs）に大別される。IIPs はさらに複数の臨床病型に分類されるが、最も頻度が高いのが特発性肺線維症（idiopathic pulmonary fibrosis：IPF）である。IPF は主に高齢者に発生し慢性かつ進行性の経過をたどり、高度の線維化が進行して不可逆性の蜂巣肺をきたす予後不良疾患である。IPF の原因は不明であるが、多様な遺伝子背景に加えて、環境因子の影響を受ける慢性炎症や繰り返される肺胞上皮傷害の修復過程で発現する異常な線維化がメカニズムとして提唱されている。喫煙は直接の原因ではないが危険因子として重要である。また、肺胞サーファクタント蛋白やその放出機序にかかわる特定の遺伝子多型との関連が報告されており、遺伝性が明確なものは家族性間質性肺炎として区別される。

IPF は通常、緩徐で慢性進行性の経過をたどるが、進行速度には個人差が大きく、一個人内でも一定でない。さらに年間5～10％程度の頻度で、慢性進行とは明らかに異なる急性増悪を呈することがある。急性増悪はIPF の最終死因の4割を占め、臨床でも大変重要であり、病態としては、既存の線維化病変にオーバーラップした急性肺胞傷害がみられる。

b 疫学

発症早期の段階では未診断であることも多く、正確な把握は困難といわれているが、近年の高分解能CT（HRCT）画像診断の向上により、従来、報告されていたよりも多くの罹患患者の存在が認識されている。

米国データで10万人あたり14.0～42.7人と報告されている。

日本では厚生労働省の管理する匿名医療保険等関連情報データベースをもとにした疫学調査にて、10万人あたり27人、平均年齢は73歳で男性が73％を占めると報告されている¹⁾。

症候・身体所見

検診発見例では無症状の場合もある。初発症状としては乾性咳嗽、労作時呼吸困難が多い。身体所見では90％以上の患者に聴診上捻髪音（fine crackles）を認めるが、発症早期には背側肺底部の深吸気時に限られる。また30～60％の患者にバチ指（clubbed finger）を認め、これは他のIIPsとの鑑別に重要な所見であるとともに予後不良な指標でもある。病態が進行すると体重減少や倦怠、疲労、さらに二次性肺高血圧に伴う浮腫や失神を呈することがある。

診断・検査

a 診断の基本

i) 診断指針の概略

びまん性肺疾患の診断に際しては、詳細な病歴聴取や身体診察を行い、感染症、腫瘍性病変、吸入によるものや薬剤性肺炎、膠原病・サルコイドーシスなどの全身性疾患に付随する二次性間質性肺炎を鑑別する。IPFを疑う場合には、HRCTは必須の検査であり、これに臨床情報を組み合わせて臨床診断する。生検が行われて病理組織学的な評価が行われる場合には、IPFの病理組織型である通常型間質性肺炎（usual interstitial pneumonia：UIP）パターンを示すことが重要である。臨床情報に加えて典型的なHRCT所見が得られれば、IPF診断には外科的肺生検（SLB）は不要である（図1）²⁾。

日本の『特発性間質性肺炎診断と治療の手引き 改訂第4版』は、国際的ガイドライン（2018）と整合性をもって作成され、SLBが実施された症例では、HRCTパターンと病理組織パターンはそれぞれ4段階（UIP, probable UIP, indeterminate for UIP, alternative diagnosis）に分類され、これらの組み合わせの4×4表に基づき、総合的にIPFの診断が行われる。その後国際ガイドラインは2022年に改訂され、表も変更されているため、本書では2022年版を示す。